

Diarreia Crônica



ROTINA CLÍNICA

Type 1		Separate hard lumps, like nuts (hard to pass)
Type 2		Sausage-shaped but lumpy
Type 3		Like a sausage, but with cracks on the surface
Type 4		Like a sausage or snake, smooth and soft
Type 5		Soft blobs with clear-cut edges (passed easily)
Type 6		Fluffy pieces with ragged edges, a mushy stool
Type 7		Watery, no solid pieces (entirely liquid)

Definição

- Diarreia é definida, na prática clínica, como:
- **Aumento do número de evacuações** (em geral, 03 ou mais evacuações por dia) **E alteração de consistência das fezes** (aumento do teor líquido), com fezes amolecidas/pastosas ou líquidas;
- Essa é a definição pela **OMS e MS**, além da maioria das referências consolidadas sobre este tema.



Duração

- A diarreia pode ser classificada de acordo com sua duração em:
- Aguda: Duração inferior a 2 semanas;
- Persistente: Duração entre 2 a 4 semanas;
- **Crônica: Duração superior a 4 semanas.**

Topografia

- A diarreia pode ser classificada topograficamente em:
- **Alta (Intestino Delgado):** Fezes **volumosas**, com **menor frequência** dos episódios; **Sem tenesmo** (sensação de evacuação incompleta e/ou vontade intensa ou constante de evacuar sem a presença de bolo fecal no intestino); **Com restos alimentares**; Perda líquida pode ser superior a 10L por dia (casos graves);
- **Baixa (Cólon):** Fezes com **pouco volume**, **alta frequência** (pode ser maior que 10 episódios/dia); **com tenesmo**; **Sem restos alimentares**.

Mecanismo Fisiopatológico

- **Diarreia Osmótica:** A presença de substrato/substância **não absorvível** pelo epitélio e **osmoticamente ativa** no meio intraluminal provoca movimento de fluídos do intravascular para a luz do trato gastrointestinal.
- Exemplos de causas: Ingestão de íons não absorvíveis e intolerância a lactose.
- A diarreia osmótica, em geral, **melhora com o jejum** e não há diarreia noturna.

Mecanismo Fisiopatológico

- **Diarreia Secretória:** Toxina, droga ou substância neuro-hormonal atua estimulando a secreção ou inibindo a absorção hidroeletrolítica epitelial intestinal;
- Exemplos: Uso de bisacodil (laxante estimulante/irritativo); bactérias produtoras de toxinas (cólera) e síndrome carcinoide;
- **Não melhora com o jejum!!**

Mecanismo Fisiopatológico

- **Diarreia Inflamatória ou Invasiva:** Liberação de citocinas ou mediadores inflamatórios associados a **lesão direta da mucosa intestinal** (enterite, colite ou enterocolite), gerando aumento da motilidade e secreção intestinal. Marcada pela presença de **sangue, muco ou pús nas fezes**;
- Pode ser infecciosa ou não (como no caso das DII).



Mecanismo Fisiopatológico

- **Diarreia Funcional/Motora:** Causada pela hipermotilidade intestinal.
- Principais exemplos: Síndrome do Intestino Irritável e Diarreia Diabética (neuropatia autonômica).
- **Diarreia Disabsortiva:** Associada com deficiência no processo de digestão dos alimentos e/ou lesões parietais do intestino delgado com redução da capacidade absorptiva.
- Exemplo: Acarbose, Orlistate, Supercrescimento bacteriano.

Diarreia Agudas: Resumo Prático

- Em geral, possuem etiologia **INFECCIOSA!!**
- Viral: Mais comum, Norovírus (Adulto) x Rotavírus (menores de 2 anos, casos graves);
- Peço exames apenas **se sinais de alarme**: Paciente com desidratação, sangue nas fezes, febre, sem melhora após 48 horas, idosos, imunocomprometidos e pacientes com uso recente de antibióticos;
- Solicitar: Hemograma, Sódio, Potássio, Ureia e Creatinina;
- Se sinal de alarme: Tratamento com **antimicrobiano** e **não usar antidiarreico**.

Diarreia Agudas: Resumo Prático

- Caso sinais de alarme/suspeita de **etiologia bacteriana**:
 - Tratamento com **antimicrobiano**;
 - Sugestão: Ciprofloxacino 500 mg, VO, 12/12h, por 3 a 5 dias.
 - Alternativas: Azitromicina e Sulfametoxazol+Trimetoprima.
-
- Prescrever também:
 - Sintomáticos (analgésicos e antieméticos, se necessário);
 - Hidratação com Soro de Reidratação Oral (SRO).

Diarreia Agudas: Resumo Prático

- Caso paciente **sem sinais de alarme/alterações sugestivas de etiologia bacteriana**, podemos utilizar (com racionalidade) os antidiarreicos:
- Cloridrato de Loperamida – **Antimotilidade** (“reduz movimentos peristálticos propulsivos, eleva o tempo de trânsito intestinal e aumenta o tônus do esfíncter anal”). Sugestão: 4 mg (2 cp) + 2 mg (1 cp) a cada evacuação). Dose máxima de 16 mg/dia.
- Racecadotril – **Antissecretor** (“reduz a hipersecreção intestinal de água e eletrólitos”). Sugestão: 1 cápsula (100 mg), uma vez ao dia.

Diarreia Crônica

- A diarreia está associada com comprometimento da **qualidade de vida** do indivíduo;
- Estudos americanos relatam prevalência de diarreia crônica em **3% a 7%** da população adulta;
- Em países com baixo nível socioeconômico, predominam etiologias infecciosas;
- Em países desenvolvidos, a síndrome do intestino irritável (SII), doença inflamatória intestinal (DII), síndromes de má absorção e infecções crônicas (especialmente nos imunocomprometidos) são as causas mais comuns.

Intolerância a lactose

- Lactose: Dissacarídeo (carboidrato), formado por glicose e galactose;
- Causa: Deficiência enzimática (Lactase) – Primária (congenita ou hipolactasia do adulto) x Secundária (lesão de mucosa);
- Fisiopatologia: Lactose permanece na luz intestinal e é fermentada por bactérias intestinais;
- Manifestações Clínicas: Intolerância a leite e derivados, apresentando sensação de plenitude abdominal, dor abdominal em cólica, flatulência e diarreia. Detalhe: Sintomas melhoram após retirada/redução de lactose da dieta.

Primary
Race and ethnicity
Developmental enzyme deficiency
Congenital lactase deficiency
Secondary
Small intestinal bacterial overgrowth
Infectious enteritis
Giardiasis
Mucosal injury
Celiac disease
Inflammatory bowel disease (especially Crohn disease)
Drug- or radiation-induced enteritis

Intolerância a lactose

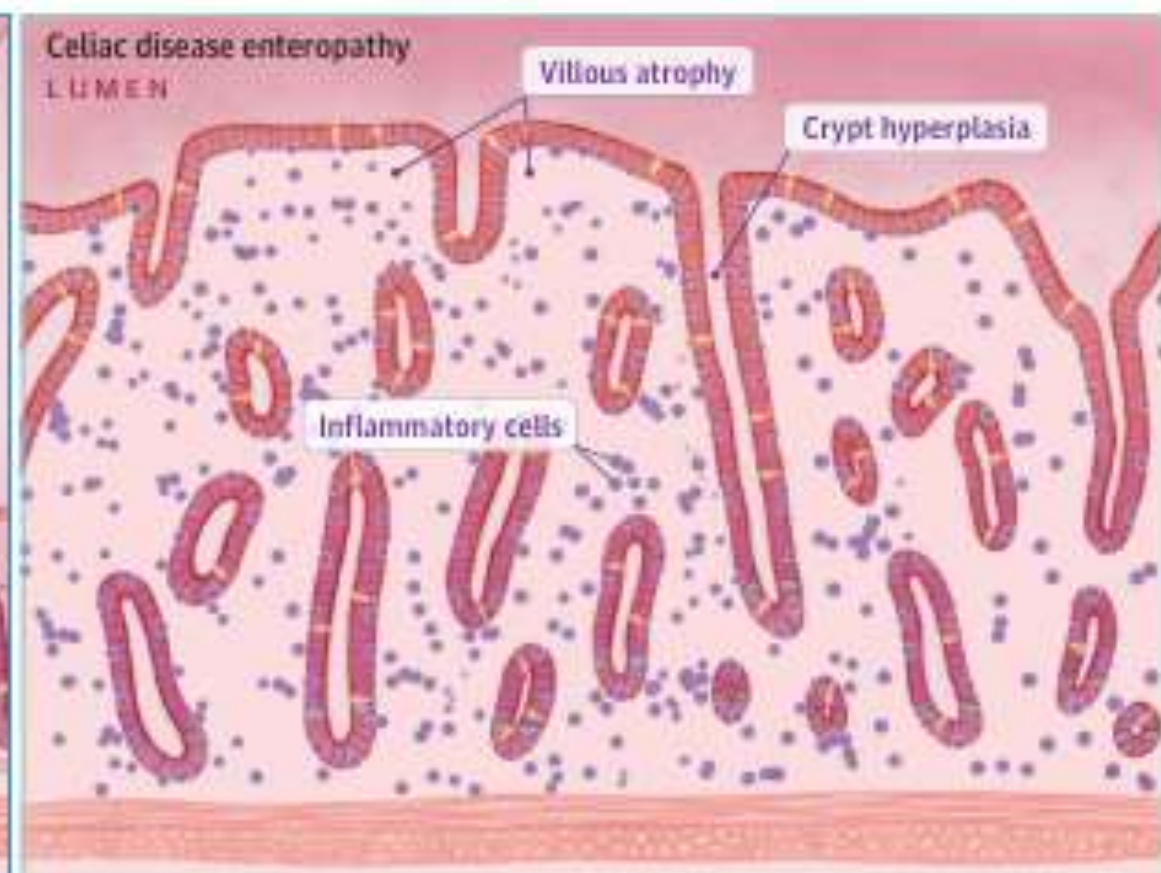
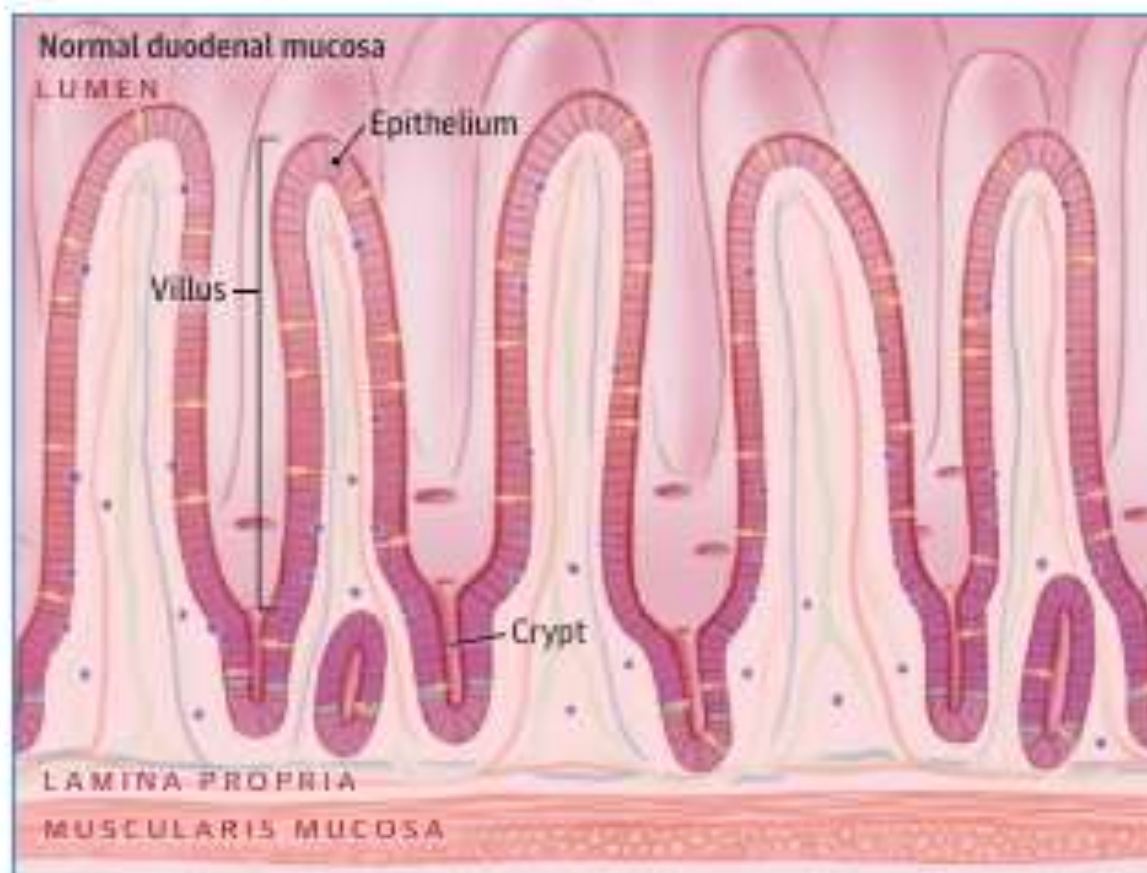
- Diagnóstico: História clínica compatível; **Teste do Hidrogênio Expirado com Lactose** (25 gramas de lactose por via oral -> Ação fermentativa de bactérias produz a liberação de gás hidrogênio, que se difunde pelas paredes do intestino até a corrente sanguínea, sendo expirado posteriormente e medido em intervalos pré-definidos);
- Tratamento: Reduzir/cessar ingestão de leite e derivados; Fazer uso de lactase (idealmente 30 minutos antes das refeições); manter consumo adequado de vitamina D e cálcio (suplementação se necessário).

Doença Celíaca

- Glúten: Proteína presente no **trigo, centeio e cevada**;
- Causa: Autoimunidade; associação com HLA-DQ2 e DQ8;
- Fisiopatologia: Glúten é parcialmente digerido e libera Gliadina → Gliadina se liga a enzima transglutaminase tecidual → Este complexo é reconhecido como antígeno por células apresentadoras que possuem os alelos HLA-DQ2 (95%) e DQ8 (5%) → Ocorre ativação de processo imune com **infiltração e inflamação da mucosa** e formação de anticorpos.



A Overview of structural changes in the intestinal mucosa in celiac disease



Doença Celíaca

- Manifestações Clínicas: Condição subdiagnosticada (maioria é oligo/assintomático); Manifestações estão relacionadas com o grau de acometimento da mucosa do intestino delgado;
- **Típicas**: Distensão abdominal, diarreia crônica com esteatorreia, flatulência, perda ponderal;
- **Atípicas (extraintestinais)**: Anemia ferropriva, depressão, fadiga, amenorreia, **dermatite herpetiforme** (rash papulovesicular pruriginoso, mais evidente em áreas extensoras, no tronco, couro cabeludo e pescoço).



Doença Celíaca

- Diagnóstico: História clínica sugestiva; Solicitar anticorpos característicos (**IgA Antitransglutaminase tecidual – 95% de Sensibilidade e Especificidade**); Se negativo: Dosar IgA total sérica;
- Antigliadina e Antiendomísio são outros anticorpos a serem avaliados*;
- Podemos realizar pesquisa de HLA DQ2 e DQ8 no sangue periférico;
- **Sempre realizar endoscopia digestiva alta (EDA) com biópsia de intestino delgado (duodeno) para avaliação histopatológica (Padrão-Ouro)**;
- Macroscopia: Atrofia e aplainamento de dobras mucosas e vilosidades;
- Microscopia: Infiltrado linfocítico no epitélio e lâmina própria, com atrofia de vilosidades e hiperplasia das criptas.

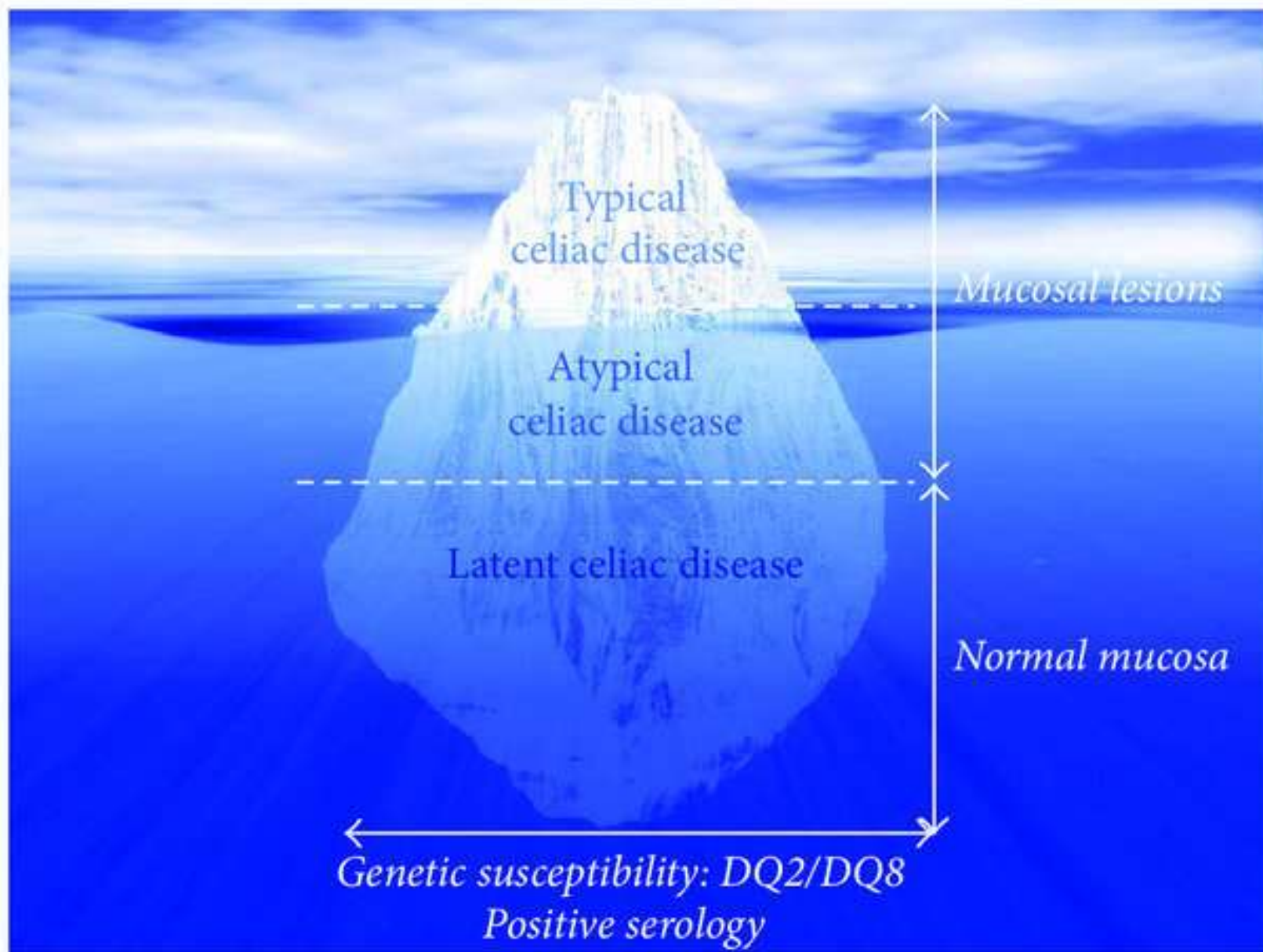
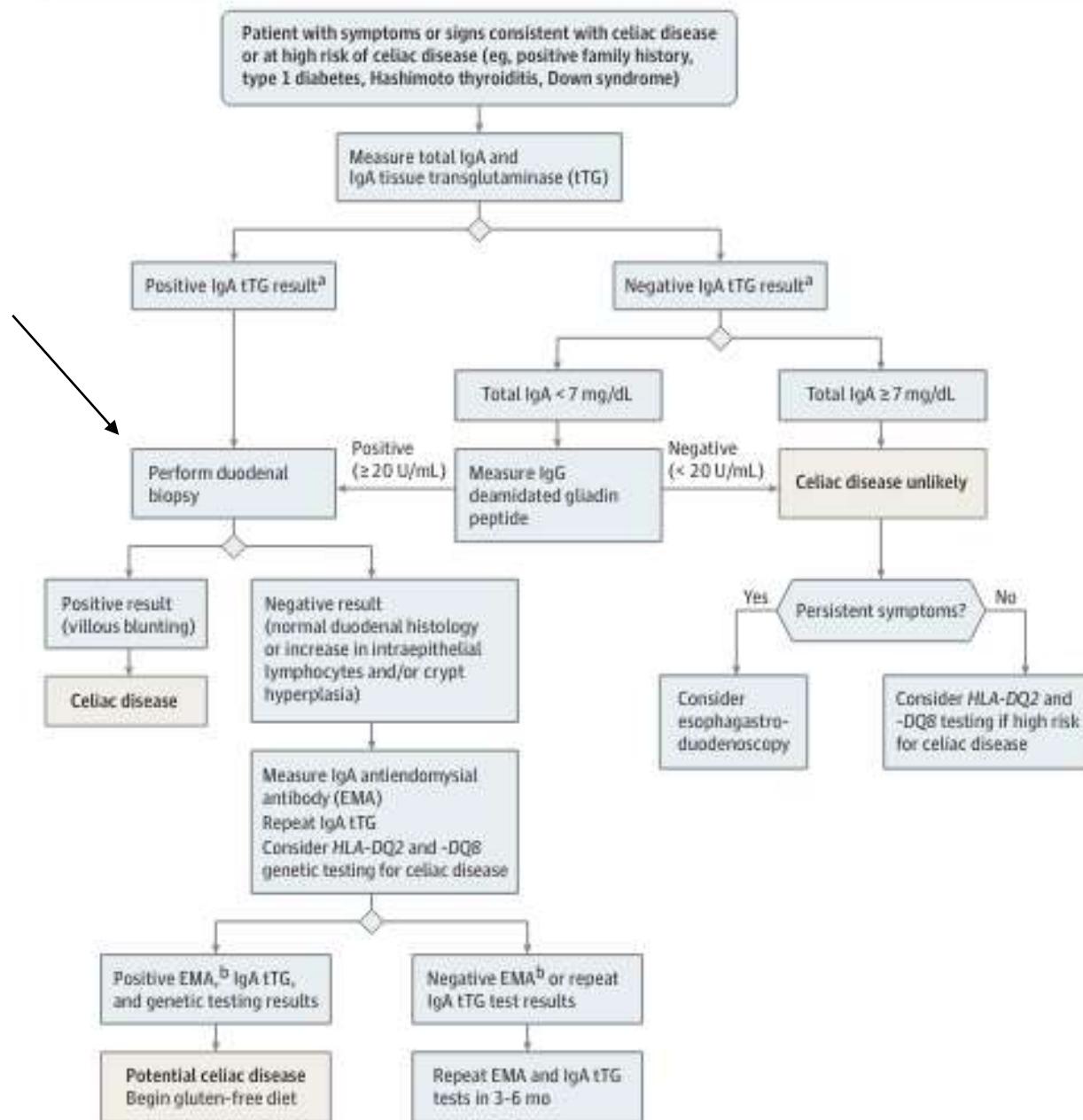


Figure 2. Proposed Screening Algorithm for Celiac Disease



^a Reference values for IgA tTG vary depending on the source of the tTG used (recombinant tTG vs tTG purified from human red blood cells) and kit-specific range (cutoff ranging from <4 U/mL to <20 U/mL).

^b Cutoff for EMA is 1:5 dilution (subjective immunofluorescence method).

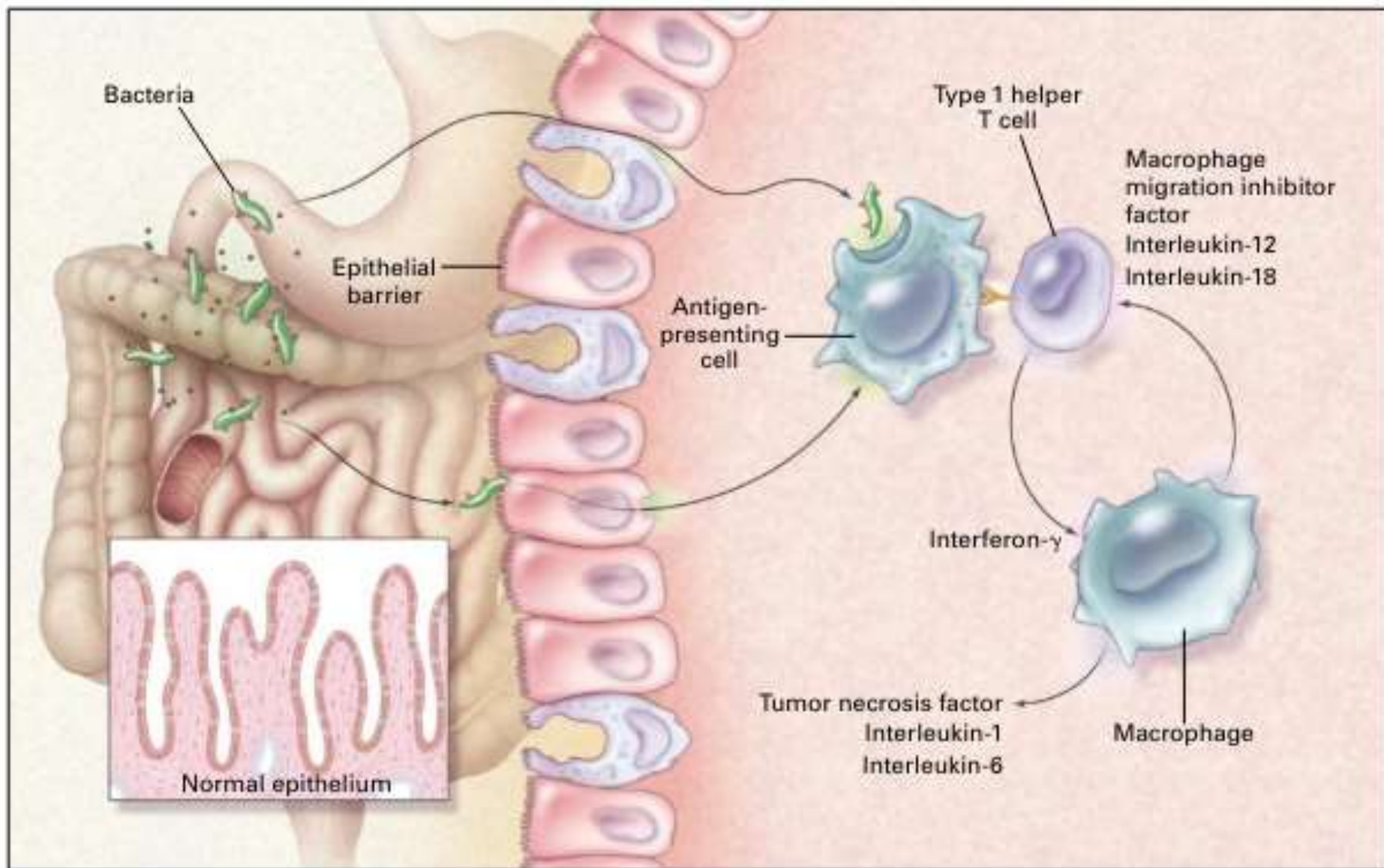
Doença Celíaca

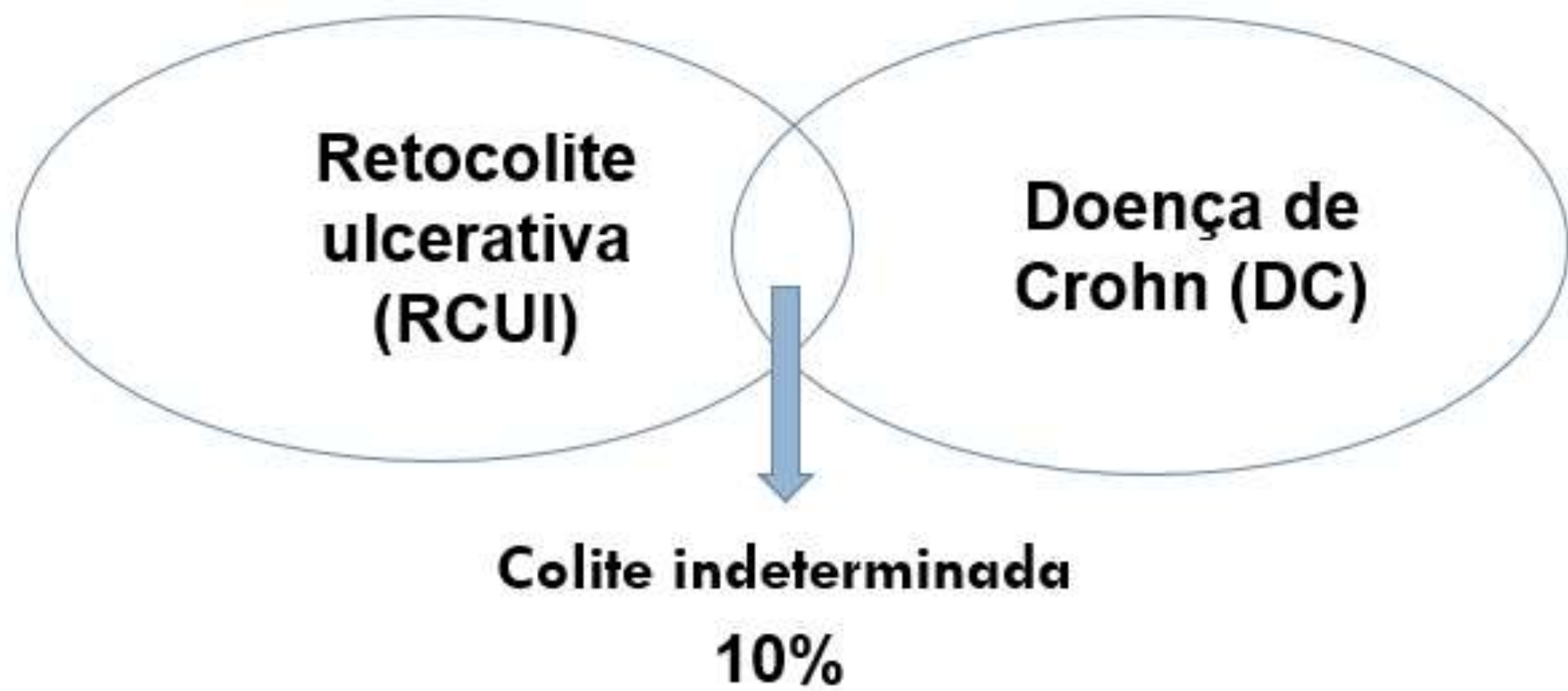
- Tratamento: **Dieta sem glúten**;
- Paciente aderente à dieta apresenta melhora completa das queixas em poucas semanas e prognóstico excelente;
- Menos de 5% dos pacientes podem persistir com os sintomas mesmo com a dieta adequada ou apresentar recidiva dos sintomas, nestes casos está indicado a prescrição de corticoides e/ou imunossupressores.



Doença Inflamatória Intestinal (DII)

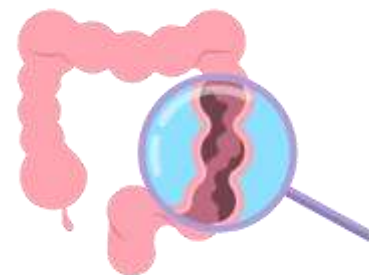
- O termo DII se aplica a duas doenças inflamatórias intestinais crônicas e idiopáticas: **Doença de Crohn (DC)** e **Retocolite Ulcerativa (RCU)**;
- Fisiopatologia: Inflamação crônica do TGI associada com predisposição genética;
- A diferenciação entre DC e RCU é baseada em **critérios clínicos, radiológicos, endoscópicos e histológicos**;
- Sabe-se, entretanto, que em 10 a 20% dos indivíduos, não é possível classificar o paciente como portador de DC ou RCU (colite indeterminada).





Doença Inflamatória Intestinal (DII)

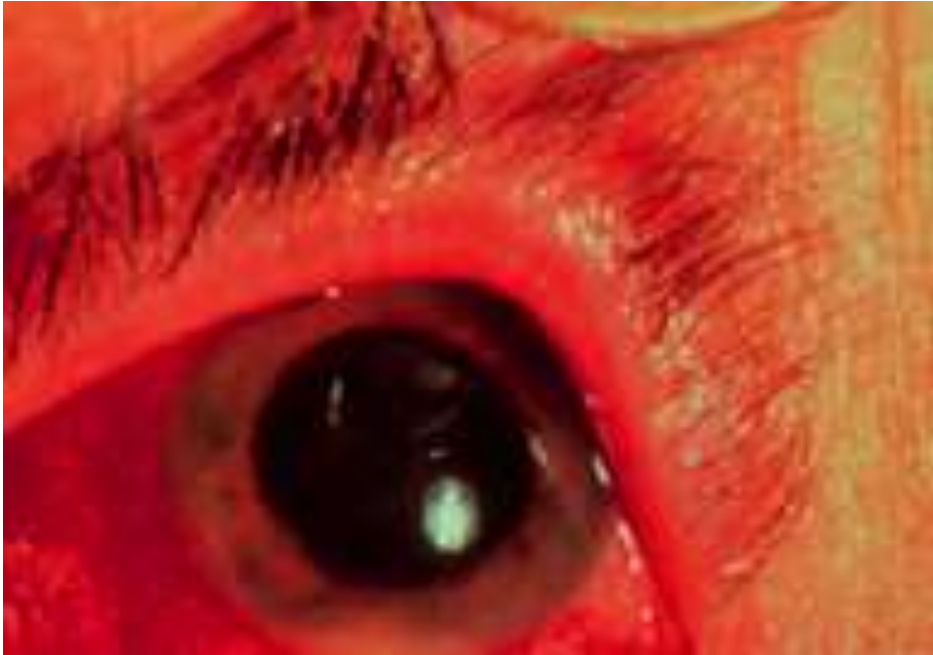
- Manifestações Clínicas:
- **RCU:** Diarreia sanguinolenta ou com muco, dor abdominal, urgência para defecar, sensação de esvaziamento retal incompleto, entre outras;
- **DC:** Diarreia invasiva, dor abdominal, febre, anorexia e perda ponderal, doença perianal, massa palpável em QID (alça edemaciada ou abscesso intra-abdominal), entre outras;
- Manifestações Extra-Intestinais: Articulares; Cutâneas, Oculares (uveíte); Renais; Ósseas (osteoporose), entre outras.



Pioderma Grangrenoso (+DC)



Uveíte Anterior(+DC)

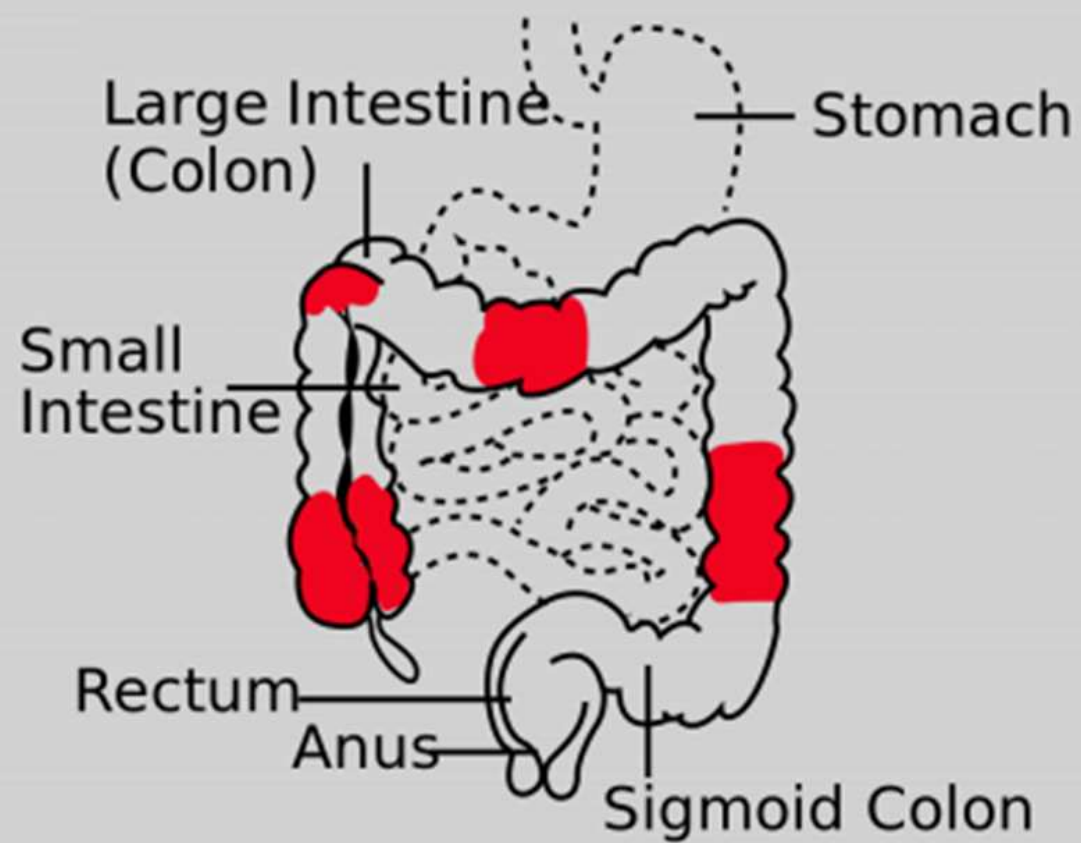


Eritema nodoso (+DC)

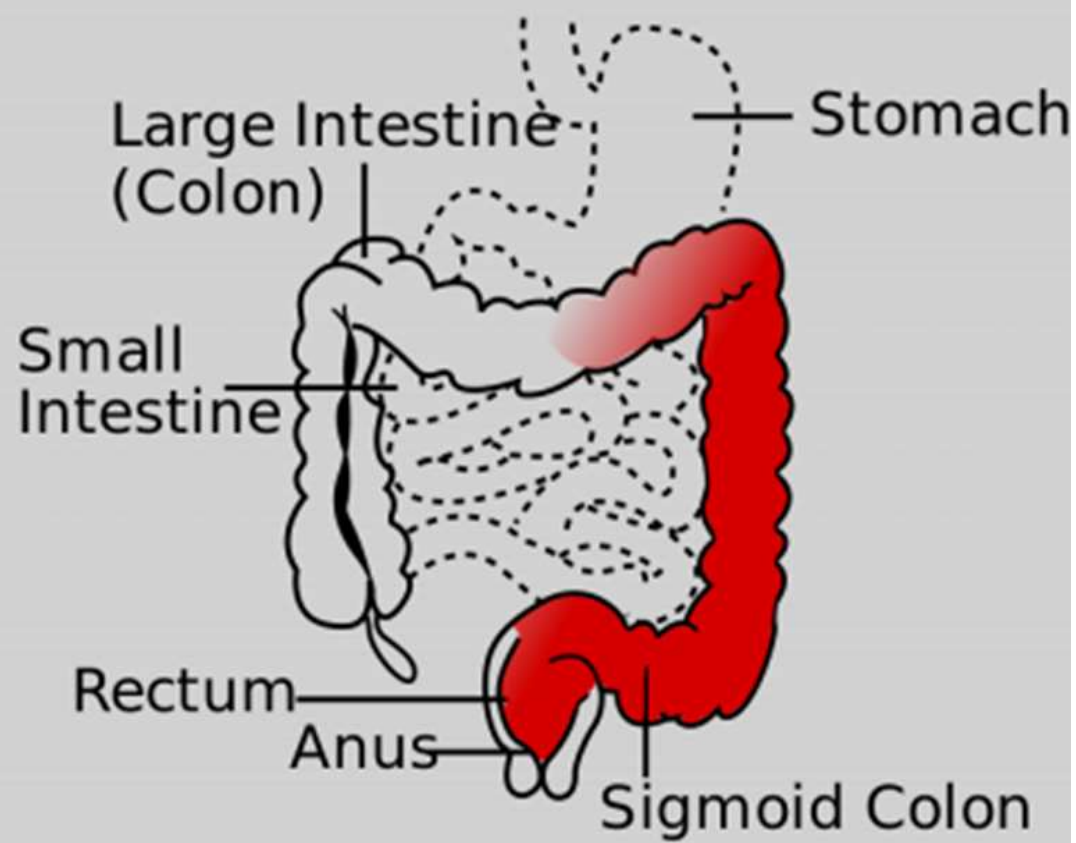


Doença Inflamatória Intestinal (DII)

- Diagnóstico: Envolve história clínica, alterações em exame de colonoscopia, alterações histológicas e alterações em exames laboratoriais; **Não existe exame padrão-ouro para o diagnóstico**;
- Colonoscopia com biópsia é fundamental;
- Avaliação sorológica (p-ANCA x ASCA) pode ser realizada;
- Calprotectina fecal (Importante marcador de **atividade inflamatória intestinal**, com boa correlação com índices endoscópicos).

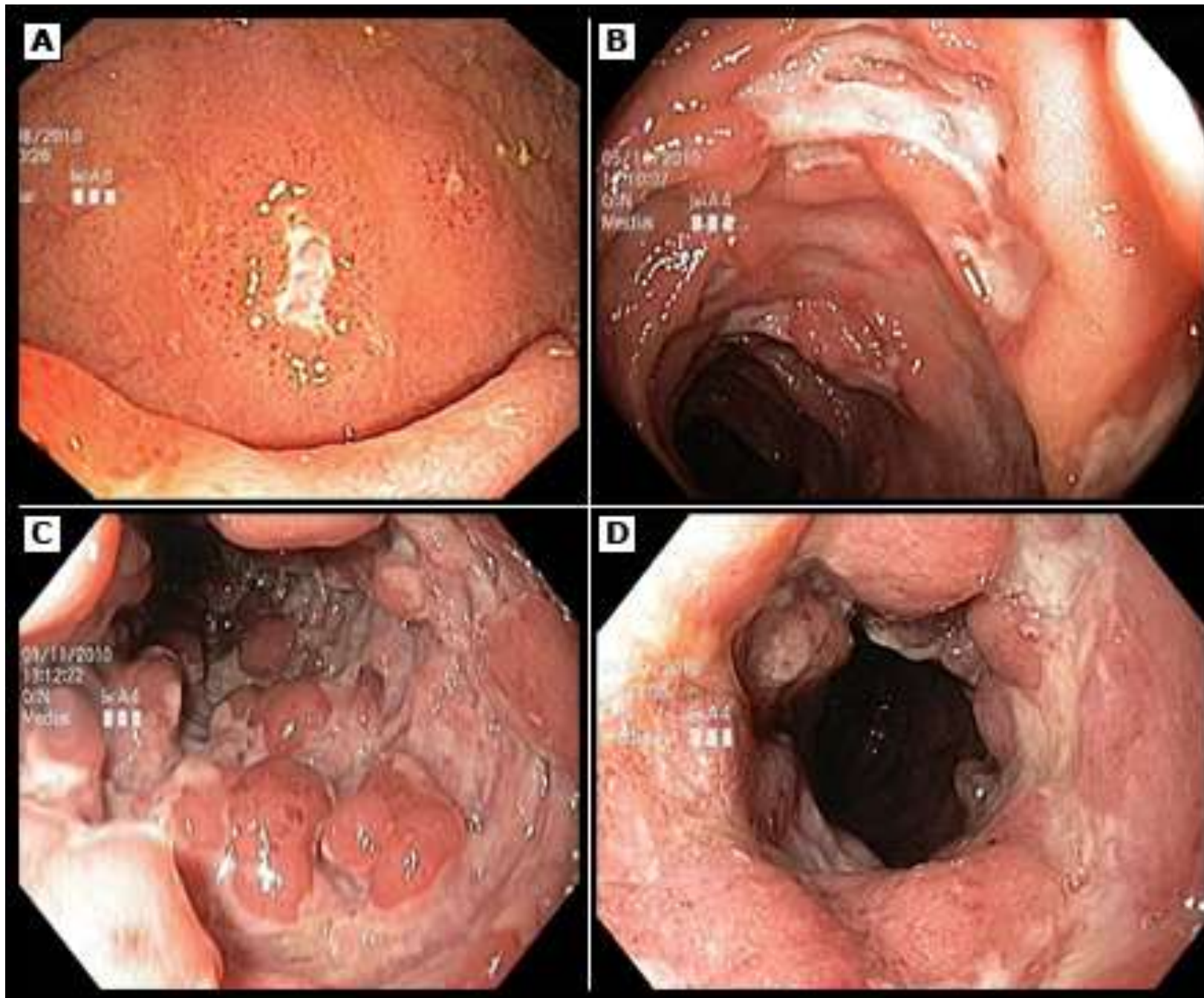


Crohn's Disease



Colitis ulcerosa

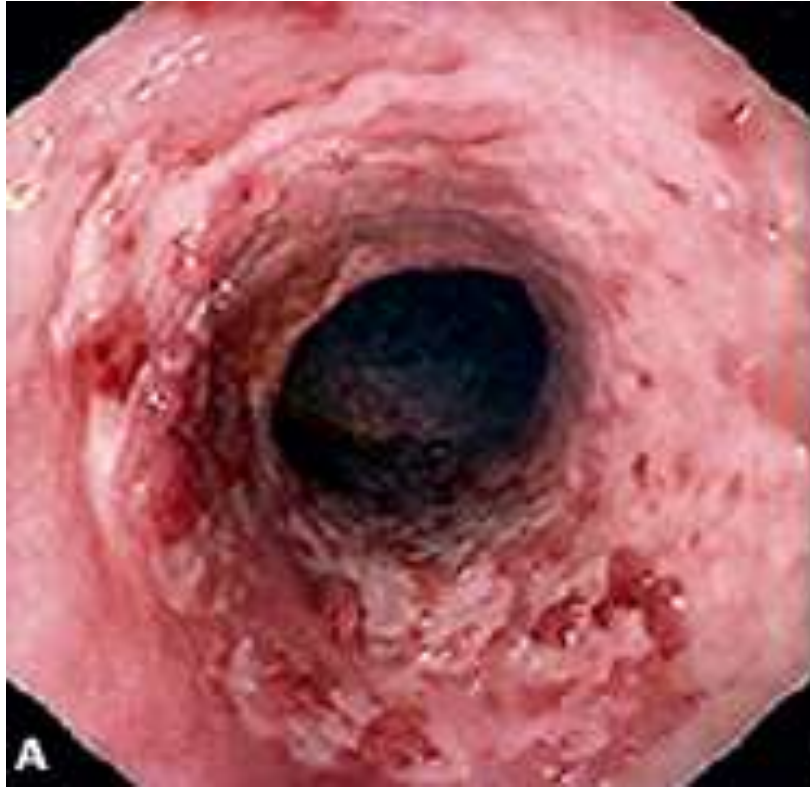
DC



Montreal classification for Crohn disease

Age at diagnosis
A1 below 16 years
A2 between 17 and 40 years
A3 above 40 years
Location
L1 ileal
L2 colonic
L3 ileocolonic
L4 isolated upper disease*
Behavior
B1 nonstricturing, nonpenetrating
B2 stricturing
B3 penetrating
p perianal disease modifier¶

RCU



	Doença de Crohn	Retocolite Ulcerativa
Tabagismo	Fator de Risco	Fator de Proteção
Marcador Sorológico	ASCA	p-ANCA
Localização no TGI	“da boca ao ânus”	Cólon
Inflamação	Transmural (todas as camadas)	Superficial
Padrão das lesões	Descontínuas/Salteadas	Contínua e ascendente
Complicações	Fístulas e estenoses	Colite e megacólon tóxico
Associação com CCR	Sim, porém inferior a RCU	Alta
Macroscopia	Lesões ulceradas salteadas	Lesões ulceradas contínuas
Microscopia (biópsia)	Granuloma não caseoso	Criptite, microabscessos
Quadro Clássico	Diarreia, dor abdominal e emagrecimento	Diarreia baixa disentérica (sangramento e/ou muco)
Especificidades	Úlceras aftoides, Estenoses, lesões em pedras de calçamento, presença de fístulas, fissuras perianais.	Erosões, perda das haustrações, presença de pseudopólipos.

Doença Inflamatória Intestinal (DII)

- **Complicações:**
- DC: Fístulas e Estenoses;
- RCU: Colite e megacólon tóxico*;
- **Detalhamento do Megacólon tóxico:**
- “É uma complicação potencialmente fatal, geralmente associada à doença inflamatória intestinal ou colite infecciosa, caracterizada por **dilatação colônica não obstrutiva, total ou segmentar, associada à toxicidade sistêmica**”.
- Tratamento inicial envolve suporte clínico, hidratação e corticoide endovenoso (hidrocortisona 100 mg, EV, 8/8h ou 6/6h*).

Critérios Diagnósticos

Megacólon tóxico (critérios de Jalan):

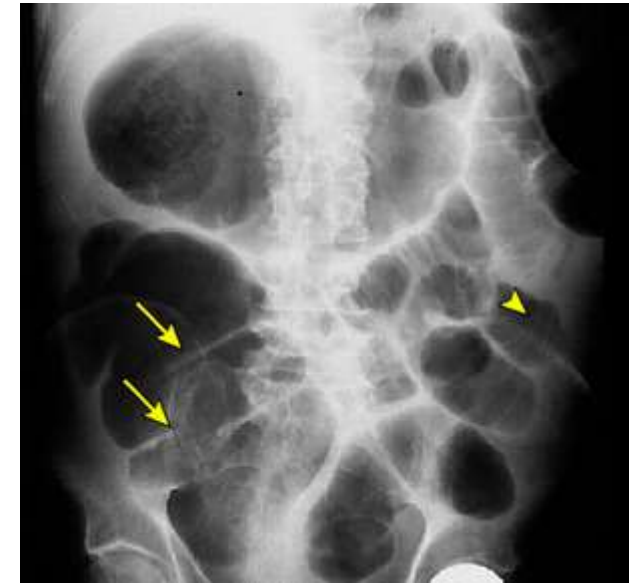
A. Evidência radiográfica de dilatação colônica (diâmetro > 6 cm).

B. Pelo menos três dos seguintes critérios:

- Febre $> 38^{\circ}\text{C}$;
- FC > 120 bpm;
- Leucocitose (com neutrofilia) > 10.500 células/ mm^3 ;
- Anemia.

C. Pelo menos um dos seguintes critérios:

- Desidratação;
- Alteração do sensório;
- Distúrbio eletrolítico;
- Hipotensão.



Doença Inflamatória Intestinal (DII)

- Tratamento:
- Medicamentoso: Derivados 5-ASA; Corticoide; Anti-TNF (Infliximabe), entre outros;
- Cirurgia: Complicações e casos refratários;
- Princípio do **Step Up x Top Down**:
- Doença leve a moderada: Iniciar com drogas menos potentes e ajustar esquema se intolerância ou refratariedade;
- Doença grave: Iniciar com drogas mais potentes e ajustar esquema após controle clínico adequado.

TABLE 3. THERAPEUTIC OPTIONS FOR ULCERATIVE COLITIS AND CROHN'S DISEASE.

VARIABLE	DISTAL ULCERATIVE COLITIS	EXTENSIVE ULCERATIVE COLITIS	CROHN'S DISEASE
Mild disease	Oral or rectal aminosalicylates Rectal corticosteroids	Oral aminosalicylates	Oral aminosalicylates Oral metronidazole Possibly oral budesonide or ciprofloxacin
Moderate disease	Oral or rectal aminosalicylates Rectal corticosteroids	Oral aminosalicylates	Oral corticosteroids (budesonide for ileal or right-sided colonic disease) Oral azathioprine or mercaptopurine
Severe disease	Oral or parenteral corticosteroids Rectal corticosteroids	Oral or parenteral corticosteroids Intravenous cyclosporine	Oral or parenteral corticosteroids Subcutaneous or intravenous methotrexate Intravenous infliximab
Refractory disease	Oral or intravenous corticosteroids, in addition to oral azathioprine or mercaptopurine	Oral or intravenous corticosteroids, in addition to oral azathioprine or mercaptopurine	Intravenous infliximab
Perianal disease	—	—	Oral antibiotic (metronidazole or cipro- floxacin) Intravenous infliximab Oral azathioprine or mercaptopurine
Remission	Oral or rectal aminosalicylates Oral azathioprine or mercaptopurine	Oral aminosalicylates Oral azathioprine or mercaptopurine	Possibly oral azathioprine or mercaptopur- ine, mesalamine, metronidazole Oral azathioprine or mercaptopurine

Doença Inflamatória Intestinal (DII)

- **Medicações que podem ser utilizadas nos esquemas terapêuticos:**
- DC: Prednisona, Azatioprina, Metotrexato, Infliximabe, Adalimumabe, Vedolizumabe, Ustekinumabe, entre outros.
- RCU: Mesalazina (Enema ou supositório), Mesalazina (Oral), Prednisona, Azatioprina, Infliximabe, entre outros.

Síndrome do Intestino Irritável

- **Diarreia funcional/motora com fisiopatologia ainda não completamente elucidada;**
- Pode ser chamada de “pseudodiarreia” (menos de 200g de perda fecal diária);
- É uma das causas mais comuns de diarreia crônica em países industrializados;
- É mais comum em mulheres, afetando cerca de 10 a 20% da população mundial;
- Quadro Clínico: Dor abdominal em cólica e alteração do hábito intestinal (maioria alterna períodos de diarreia e constipação intestinal).

Critérios de ROMA IV

O paciente necessariamente tem que ter DOR ABDOMINAL recorrente, em média, pelo menos 1 vez por semana nos últimos 3 meses, associada a 2 ou mais dos seguintes critérios:

- 1) Relacionada a defecação;
- 2) Associada com a mudança na frequência das evacuações/fezes;
- 3) Associada com mudança na forma/aparência das fezes.

Lembrando que os critérios devem ser preenchidos nos últimos 3 meses, porém com sintomas definidos por pelo menos 6 meses anteriores ao diagnóstico.

Síndrome do Intestino Irritável

- Tratamento:
- Estimular a prática de atividade física regular;
- Em pacientes com ansiedade e depressão, devemos tratar os transtornos psiquiátricos (medicamentoso e psicoterapia);
- Orientar sobre benignidade do quadro;
- Sintomáticos sob demanda e orientar ajustes na dieta , se possível com seguimento com nutricionista (avaliar redução de glúten, lactose, evitar ingestão de cafeína, álcool e alimentos apimentados).



Diarreia crônica associada com medicações

- Diversos mecanismos (varia de acordo com a medicação);
- **Osmótica:** Magnésio, Fosfatos, Sorbitol;
- **Hipermotilidade:** Laxativos, Pró-cinéticos (metoclopramida);
- **Secretora:** Antimicrobianos, AINEs, Metformina, Quimioterápicos);
- **Disabsortiva:** Acarbose (anti-sacaridase), Orlistate (anti-lipase);
- **Diarreia factícia*:** Paciente faz uso voluntário de laxativos ou manipula o material fecal para simular uma diarreia verdadeira (Pesquisar magnésio nas fezes e laxativos na urina).

Diarreia crônica associada infecções

- **Protozoários:**
- Amebíase (*Entamoeba histolytica*): Diarreia baixa invasiva. Pode evoluir com forma extraintestinal (abscesso amebiano);
- Giardíase (*Giardia lamblia*): Diarreia alta não invasiva (“atapeta” o intestino). Componente importante de disabsorção!!;
- **Tratamento:** Pode-se utilizar Metronidazol (ou outros nitroimidazólicos).



Diarreia crônica associada infecções

- **Helmintos:**

- Ascaridíase; Toxocaríase; Ancilostomíase; Estrongiloidíase; Enterobíase (Oxiuríase); Tricuríase (Prolapso retal*);

- **Platelmintos:**

- Teníase (Solium – porco x Saginata – boi); Esquistossomose.



Diarreia crônica e HIV

- Patogênese complexa e multifatorial;
- A prevalência de diarreia entre os pacientes com HIV aumenta de acordo com **queda no CD4**, sendo um fator independente para mortalidade;
- Os sintomas variam desde **diarreia moderada e autolimitada até casos graves com síndrome de má-absorção, desidratação e choque**;
- Até 40% dos pacientes com HIV apresentam diarreia com duração de até um mês e **25% cursam com diarreia crônica** durante algum estágio da doença.

Screening do CCR

- O câncer colorretal (CCR) é a 3ª principal causa de câncer nos homens e a 2ª nas mulheres no mundo.
- No Brasil, é o **3º câncer mais incidente entre homens e mulheres**, sendo a 5ª causa de óbito por câncer entre homens e a 3ª entre as mulheres.
- A mortalidade apresenta-se em queda no ocidente desde 1980, possivelmente associada ao **screening**.

Screening do CCR

- A maioria dos casos ocorre de forma **esporádica**, mas sua ocorrência pode estar associada com **síndromes genéticas** como **polipose adenomatosa familiar (PAF)** ou **síndrome de Lynch (SL)**.
- **Fatores de risco:** Idade avançada, Doença inflamatória intestinal, HF ou pessoal de CCR, ou pólipos adenomatosos >1 cm, pólipos com histologia vilosa ou tubulovilosa, ou presença de displasia de alto grau, Obesidade, Exposição à radiação abdominal e pélvica, Tabagismo e etilismo, DM e resistência à insulina.

Racional do screening

- A maioria dos CCR surge de pólipos adenomatosos que evoluem de **pequenos** (<8 mm) para **grandes** (≥8 mm) pólipos, e depois, para **displasia e carcinoma**.
- A literatura cita que a evolução do adenoma até carcinoma ocorre em, aproximadamente, **10 anos**.
- O rastreio permite a identificação de **lesões pré-malignas** ou do próprio CCR em estágio **inicial**, promovendo redução da mortalidade e maior efetividade da terapêutica. Os riscos estão associados com realização de **colonoscopia**, (possibilidade de perfuração intestinal, por exemplo).

Métodos e como realizar

- **Mais relevantes para a prática clínica:** Pesquisa de sangue oculto nas fezes [S: <50%; E: 95-97%] e Colonoscopia [S: 95%; E: 90%].
- Paciente de **risco habitual**: Iniciar screening aos **45 anos** (recomendação USPSTF). Sugestão: Colonoscopia a cada 10 anos ou pesquisa de sangue oculto nas fezes anualmente.
- Já teve CCR ou pólipos adenomatosos? Possui diagnóstico de DII? Já realizou radioterapia abdominal? Algum familiar com CCR ou pólipos avançados (PA) documentados (adenoma ≥ 1 cm, displasia de alto grau, histologia tubulovilosa ou vilosa)? Quantos parentes e idade de diagnóstico? São parentes de 1º grau?

Métodos e como realizar

- **Risco elevado:** Se HF+ para CCR ou PA em 2 parentes de 1º grau (qualquer idade) ou história de CCR, ou PA em parente de 1º grau com diagnóstico antes dos 60 anos, deve-se realizar **colonoscopia a cada 5 anos**, iniciando 10 anos antes da idade de diagnóstico do parente ou aos **40 anos**. Se HF+ para CCR ou pólipos avançados em parente de primeiro grau com ≥ 60 anos, deve-se realizar colonoscopia aos **40 anos**.
- **Quando encerrar o screening?** Decisão deve ser individualizada. Em geral, realizamos o rastreio do CCR até os 75 anos nos pacientes de risco intermediário, desde que sua expectativa de vida seja ≥ 10 anos.

Referências

- Manual do Residente de Clínica Médica – HCFMUSP;
- Clinical manifestations, diagnosis, and prognosis of Crohn disease in adults – UpToDate;
- Celiac Disease and Nonceliac Gluten Sensitivity: A Review – JAMA;
- Abordagem ao adulto com diarreia crônica em ambientes abundantes em recursos – UpToDate;
- Protocolo Diarreia Crônica - Universidade Federal de Campina Grande Hospital Universitário Alcides Carneiro.
- ACP 2023: Quais as recomendações atuais para o rastreio de câncer colorretal? - Portal Afya.
- Screening for colorectal cancer: Strategies in patients at average risk - UpToDate